

Incluir Suprahyal en el formulario o listado oficial

Plan de trabajo a 12 meses con Suprahyal ante clínico con rol administrativo · CO Colombia

Mercado CO Colombia

Decisor CA Clínico con rol administrativo

Meta Meta 1

01

Comprensión del contexto

A quién · audiencia

Clínico con rol administrativo
Colombia · IETS (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud)

Para qué · objetivo

Incluir Suprahyal en el formulario o listado oficial
Acceso inicial · barrera de cobertura

Descripción general del decisor

Este interlocutor es un clínico con rol administrativo en Colombia, donde la evaluación de tecnologías está a cargo de IETS (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud). No tiene una postura definida frente a nuevas tecnologías y evalúa cada caso de forma independiente. No enfrenta una presión particular identificada en este momento. No tiene relación previa con Adium ni conoce el portafolio. Su objeción más probable está relacionada con la lentitud de su propio proceso interno de incorporación. El objetivo de esta conversación es incluir suprahyal en el formulario o listado oficial.

Contexto del sistema

Gasto de bolsillo 13.7% (2021) · IETS (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud)
98,56% de afiliación al SGSSS al cierre de 2024 (MinSalud, BDUA + proyección DANE).

02

Datos que sustentan la propuesta

Evidencia verificada de Suprahyal

- LATINVISCO 2026 · consenso regional
25 expertos · 15 países · recomendación 1A GRADE
<https://doi.org/10.1016/j.ctim.2026.103385>
- Castro et al. 2015 · Colombia · CEA
ICER dominante · ahorro USD 576 por paciente vs terapia convencional · retrasa cirugía 3 años
<https://doi.org/10.1016/j.vhri.2015.03.018>
- Vásquez et al. 2024 · Colombia · AIP
USD 45,1M vs 50,2M a 5 años · 39.400 años libres de cirugía vs 4.280
<https://doi.org/10.1080/14737167.2024.2442461>
- Altman et al. 2015 · RWE · 79M pacientes
114 días a cirugía sin HA · 1.312 días con 5+ ciclos · p<0,001
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0145776>

Se incorpora una comparación de precio frente a las alternativas disponibles en este mercado, aportado directamente por el pagador en conversaciones previas. Hallazgo específico: asdsadsadsadasdsadsadasd.

Herramientas de economía de la salud seleccionadas por el equipo

GRADE Consenso de expertos con metodología GRADE

Recomendación con grado (por ejemplo 1A). En mercados sin agencia HTA formal tiene mayor peso que el modelo económico.

CEA Análisis de costo-efectividad / costo-utilidad (CEA / CUA)

Razón de costo-efectividad incremental (ICER). Si la tecnología es más efectiva y más barata, el resultado es dominante.

AIP Análisis de impacto presupuestal (AIP / BIA)

Diferencia neta de gasto por año y acumulada. Es el documento que un comité de presupuesto puede leer directamente.

CC Análisis de costo-consecuencia

Tabla de consecuencias. Es la herramienta más comprensible para decisores no técnicos y para el prescriptor.

RWE Evidencia de mundo real (RWE)

Medidas de efecto observado en poblaciones grandes. Es la base para justificar un AIP local o un acuerdo de resultado.

Argumento generado con esta combinación

Para clínico con rol administrativo en Colombia, con el objetivo de incluir suprahyal en el formulario o listado oficial, el argumento se construye así: Recomendación con grado (por ejemplo 1A). En mercados sin agencia HTA formal tiene mayor peso que el modelo económico. (LATINVISCO 2026 · consenso regional). Además, Razón de costo-efectividad incremental (ICER). Si la tecnología es más efectiva y más barata, el resultado es dominante. (Castro et al. 2015 · Colombia · CEA). Además, Diferencia neta de gasto por año y acumulada. Es el documento que un comité de presupuesto puede leer directamente. (Vásquez et al. 2024 · Colombia · AIP). Además, Tabla de consecuencias. Es la herramienta más comprensible para decisores no técnicos y para el prescriptor. (Altman et al. 2015 · RWE · 79M pacientes). Además, Medidas de efecto observado en poblaciones grandes. Es la base para justificar un AIP local o un acuerdo de resultado. (Altman et al. 2015 · RWE · 79M pacientes).

Storytelling

Escenario de la historia

Un comité de compras negociando el precio de renovación o inclusión de Suprahyal. El comprador o negociador institucional. El genérico como comparador de precio directo. Suprahyal defendiendo su valor total. El comité tiene una cotización de un ácido hialurónico genérico más barato por unidad y presiona por igualar precio o recibir un descuento significativo antes de aprobar. Cambiar la conversación de precio unitario a costo total del tratamiento a 5 años.

Desarrollo de la historia

Según Vásquez et al. 2024 · Colombia · AIP, usd 45,1m vs 50,2m a 5 años · 39.400 años libres de cirugía vs 4.280. Según LATINVISCO 2026 · consenso regional, 25 expertos · 15 países · recomendación 1a grade. Según Castro et al. 2015 · Colombia · CEA, icer dominante · ahorro usd 576 por paciente vs terapia convencional · retrasa cirugía 3 años. Según Umbrella Review IAHA 2025 · J Clin Med, eficacia moderada en oa temprana-moderada · costo-efectividad confirmada.

Conclusión · plan de trabajo a 12 meses

Acciones a corto plazo · hasta 3 meses

Comprometerse a entregar el AIP adaptado al formulario del sistema en 45 días
Preparar el dossier dual con la evidencia clínica y el AIP para el comité

Acciones a largo plazo · más de 3 meses

Presentar datos de uso y resultado a los 6 meses para reforzar la decisión
Proponer la revisión del protocolo de la especialidad con base en LATINVISCO 2026
Seguimiento del proceso de inclusión con el equipo técnico del comité

Métricas para validar los resultados

sadsadasdqwedea fcdsfdasfsazdfsdgfdgdf

El reto

Comité que evalúa con criterios clínicos y financieros al mismo tiempo

La solución

LATINVISCO 2026 + AIP de Colombia: un expediente que responde las dos preguntas

Resultados esperados

Inclusión aprobada en el formulario con respaldo técnico y financiero